

Relevanzargumentation für den leistungsorientierten Breitensport —

Rev. 2: Präventionsquellen geprüft, Gesamtbild verdichtet

Bachelorarbeit U15-Plyometrie · Befunddokument, kein Manuskripttext · Stand 28.09.2026, 15:10 MESZ, **Rev. 2 mit den Klickantworten von 14:36 und 14:57** (ersetzt Rev. 1 von 11:28 MESZ; Rev. 1 mit Präsentationsanalyse und vollständiger DOI-Liste liegt in Claude_Archiv_ersetzt_2026-09-28_Relevanz_Rev1) · Ablage Claude\02_Befunde\Argumentation_Relevanz_Breitensport_2026-09-28 (.md, .docx, .pdf), Projektkopie claude/

Auftrag (Verfasser, 28.09., 13:56): Die Quellenliste aus Rev. 1 ist für einen Teilaspekt zu lang. Rössler et al. (2014) liegt jetzt im Ordner. Die Studien sind systematisch auf ihre wissenschaftliche Durchdringung, also ihre Relevanz für das Forschungsthema, und auf ihre Passung zum Argumentationsstrang zu prüfen. Prävention bleibt ein Teilaspekt mit wenig Raum im Text, alle Überlegungen sind auf das Gesamtbild zu verdichten. Kein Textvorschlag, der folgt in einem neuen Task.

Grundlage: Rössler et al. (2014) am Volltext (16 Seiten, Tab. 1, Abb. 2 und 4). Olivier et al. (2026), Hilska et al. (2021), Price et al. (2004), Dos'Santos et al. (2018) und McBurnie, Harper, et al. (2022) am Volltext. Übrige Kandidaten über PubMed (Abstract und Metadaten, 28.09.). T1 und T4. Master in 2.1 bis 2.3 (Stand 26.09.). Maßstab F16 § 6.2, § 6.4, § 11.2b. **Zweitprüfung** durch einen Subagenten am Volltext: 19 Aussagen zu Rössler (2014) und Olivier (2026), keine falsch, vier Präzisierungen und zwei Nebenfunde übernommen.

Nachtrag 14:57 (Neuzuschnitt, § 8): Kapitel 1 bis 3 werden eine Einleitung ohne Unterabschnitte mit höchstens 1.500 Wörtern. Wo § 4 und § 6 „Kapitel 1“, „2.1“ bis „2.4“ oder die Tasks 8 bis 10 und 14 nennen, gilt diese Einleitung (Task 7 neu). Klick 3 (2.4 Fassung 7) ist gegenstandslos.

0 Ergebnis in sechs Punkten

1. **Für den Präventionsteil genügt eine Quelle.** Olivier et al. (2026) trägt den einen Satz, den die Arbeit braucht: Metaanalyse nur randomisierter Studien an 13- bis 18-jährigen männlichen Sportlern, 12 von 18 Studien im Fußball, GRADE, mehrteilige Programme mit Plyometrie als Baustein. Sie liegt im Ordner, steht in T1 und bereits im Master.
2. **Rössler et al. (2014) ist breit, für die eigene Population aber dünn.** Nur 12,7 % der Teilnehmer waren Jungen. Der Befund, der die Quelle interessant macht (Programme mit Sprungübungen RR 0,45 gegen 0,74 ohne), vergleicht Studien, nicht Übungen: 9 der 13 Sprungprogramme waren reine Mädchenstudien, keine der beiden reinen Jungen-Fußballstudien enthielt Sprungübungen, und das einzige überwiegend plyometrische Programm zeigte keinen Schutzeffekt. Für die allgemeine Aussage ist Olivier (2026) die neuere und populationsnähere Entsprechung (F16 § 6.2). Empfehlung: in T1 und T4 dokumentiert, im Text nicht zitiert. **Entscheidung (Klick 1):** Der Sprungbefund wird zusätzlich zu Olivier (2026) zitiert, als Zwischen-Studien-Vergleich mit der Population im Satz (§ 4.3).
3. **Alle übrigen Kandidaten entfallen** (§ 3): redundant zu Olivier (2026), Kinder statt Jugendlicher, Erwachsene, Kosten- oder Epidemiologieaussagen, die der Strang nicht braucht. Zu beschaffen ist nichts, H11 ist geschlossen.
4. **Prävention steht schon im Master, an der falschen Stelle.** 2.2 trägt 65 Wörter mit Hilska (2021) und Olivier (2026) samt Kennzahlen, 2.1 einen Vorverweis von 20 Wörtern. **Entscheidung (Klick 2):** Beides entfällt mit den Kürzungen (Tasks 9 und 10), dafür ein bis zwei Sätze in Kapitel 1 und ein Satzteil im Ausblick. Mit dem Sprungbefund sinkt der Präventionsanteil von 85 auf rund 65 bis 75 Wörter, unter 1 % des Umfangs.
5. **Gesamtbild** (§ 4): Leistung bleibt Hauptzweck. Die Breitensportrelevanz tragen Machbarkeit, das Zeitfenster Sommerpause und die Evidenzlücke. Prävention ist ein modalisierter Zusatznutzen der Programmklasse, kein Anspruch des eigenen Programms. 2.4 braucht keinen Relevanzabsatz, höchstens einen Satzteil zur Verletzungsrelevanz des Richtungswechsels mit einer dort schon zitierten Quelle. **Entscheidung (Klick 3):** 2.4 Fassung 7 mit diesem Satzteil und der Populationsangabe, Übergabe in 04_Uebergaben.

6. **Rev. 1 ist in sechs Punkten korrigiert** (§ 5): p-Wert aus dem Abstract, die „Brücke Plyometrie → Prävention“ überbewertet, Thorborg (2017) mit der Sekundär- statt der Hauptanalyse, Price (2004) für einen Verletzungsgipfel ohne Expositionsnenner, Kapitel 1 dem falschen Task zugeordnet, Präventionssätze in 2.1 und 6.3 vorgesehen.

1 Prüfmaßstab

Je Quelle drei Fragen. **Güte:** Evidenzstufe (F16 § 6.1) und die Einschränkungen, die eine Aussage begrenzen.

Durchdringung des Themas: Distanz zu Population, Dosis und Setting sowie Zielgröße (F16 § 6.4, je 0 bis 2) und der Anteil der Quelle, der männliche 13- bis 15-jährige Fußballer unterhalb der Akademieebene betrifft.

Passung: welche Stütze des Strangs die Quelle trägt und ob der verdichtete Strang sie braucht.

Präventionsquellen haben bei der Zielgröße immer Distanz 2, sie tragen deshalb nur Kontext (Summe ≥ 4).

2 Rössler et al. (2014) am Volltext

Merkmal	Befund	Seite
Design	Systematisches Review mit Metaanalyse, PRISMA, ohne offen zugängliches Protokoll, Suche bis 14.10.2013 · 21 Studien (13 randomisiert, 8 nicht randomisiert), 27.561 Teilnehmer, Random-Effects	1735–1736, 1741
Gesamteffekt	RR 0,54 [0,45–0,67], $I^2 = 71\%$ · nur hochwertige Studien 0,59 [0,46–0,76]	1741, 1742
Population	unter 19 Jahren, Median der Studienalter 16,7 · Jungen 12,7 % · 10 reine Mädchen-, 4 reine Jungenstudien · eine Studie ausschließlich unter 14 Jahren	1736, 1745
Fußball	9 Studien ausschließlich, 4 gemischt · Subgruppe Fußball RR 0,57 [0,42–0,79], $I^2 = 77\%$	1741, 1744
Jungen gegen Mädchen	0,71 [0,60–0,85] gegen 0,44 [0,28–0,68], $p = 0,05$ (von den Autoren als signifikant bezeichnet)	1741
Sprungübungen	mit 0,45 [0,35–0,57] gegen ohne 0,74 [0,61–0,90], $p = 0,003$ (Abstract: 0,002)	1741, 1733
Zeitpunkt	Vorbereitung, Saison oder beides ähnlich, $p = 0,93$, nur drei reine Vorbereitungsprogramme	1741
Leistungsniveau	sub-elite 0,51 gegen elite 0,67, $p = 0,11$, a posteriori, nach den Autoren explorativ · Elite-Gruppe im Text widersprüchlich (vier Studien genannt, fünf Referenzen)	1736, 1741, 1745
Güte	Qualitätsscore Ø 11,8 von 18 (6–16), kein GRADE · Funnel-Plot: kleine Studien mit neutralen Effekten fehlen möglicherweise	1741
Schluss der Autoren	mehrkomponentige Programme mit Sprung- oder plyometrischen Übungen empfehlenswert · Datenlücke bei Kindern unter 14, bei Jungen und in Einzelsportarten	1746

Was die Quelle für die Arbeit nicht trägt:

- **Eine Wirkung der Sprungübungen.** Der Subgruppenvergleich stellt Studien gegeneinander, nicht Übungen. 9 der 13 Programme mit Sprungübungen waren reine Mädchenstudien, von den 8 ohne war es eine (Tab. 1, S. 1737–1740). Mädchen profitierten insgesamt stärker, und die knie- und kreuzbandbezogenen Endpunkte häufen sich in derselben Gruppe. Die Differenz kann ebenso auf Geschlecht und Endpunkt zurückgehen. Das einzige überwiegend plyometrische Programm (Pfeiffer et al., 2006, Mädchen) zeigte keinen Schutzeffekt, RR 2,15 [0,44–10,66] (S. 1739). Die Einstufung ist zudem unscharf: Ein Lande- und Falltraining (Scase et al., 2006, Jungen) und ein Programm mit Minitrampolin

(Malliou et al., 2004) zählen zur Gruppe ohne Sprungübungen. Die Autoren diskutieren die Überschneidung von Geschlecht und Sprungübungen nicht.

- **Evidenz für männliche Jugendfußballer mit Sprungübungen.** Die beiden reinen Jungen-Fußballstudien enthielten keine Sprungübungen (Junge et al., 2002, Amateure, RR 0,79 [0,59–1,06] · Malliou et al., 2004, Elite, Gleichgewichtstraining). Die einzige Jungenstudie mit Plyometrie betraf Basketball auf Elite-Niveau (Longo et al., 2012).
- **Einen günstigen Zeitpunkt.** Die Gleichheit von Vorbereitungs- und Saisonprogrammen beruht auf drei Vorbereitungsstudien und ist kein Äquivalenzbefund.
- **„Breitensport profitiert stärker“.** Der Niveauvergleich ist a posteriori und nicht signifikant, „sub-elite“ bezeichnet überwiegend US-High-School-Spielerinnen.
- **Das Setting.** Alle Programme waren trainergeleitet und liefen meist über eine Saison, keines war unbeaufsichtigt oder videobasiert. Die Aussagen zu Leistungsgewinnen durch Präventionsprogramme (S. 1746) und zum Mechanismus Sprung und Landung (S. 1744) sind Relais auf Einzelstudien, überwiegend an Mädchen.

Urteil: Güte mittel, Durchdringung des Themas gering (Distanz 2/2/2), Passung nur für die allgemeine Aussage, die Olivier (2026) populationsnäher und aktueller trägt. Die Quelle ist geprüft und dokumentiert (T1 Roessler 2014, T4 vier Einträge, 28.09.). Nach Klick 1 wird ihr Sprungbefund zitiert, als Zwischen-Studien-Vergleich mit Population im Satz (§ 4.3).

3 Die übrigen Kandidaten

Quelle	Grundlage	Güte	Distanz P/D/Z	Durchdringung des Themas	Passung zum Strang	Urteil
Olivier et al. (2026)	Volltext	MA nur RCT, GRADE · Inzidenz RR 0,67 [0,48–0,93], I ² = 0 %, hohe Sicherheit (7 Studien, S. 6) · JBI-Score Ø 8,2 von 13, im Mittel moderates Verzerrungsrisiko	1/2/2	höchste der Schiene: männlich 13–18, 12 von 18 Studien Fußball, Plyometrie als Baustein (S. 10)	trägt den Präventionssatz	Kern
Hilka et al. (2021)	Volltext	Cluster-RCT, Randomisierung über 13 Städte	1/2/2	Kinderfußball 9–14, trainergeleitet	für Prävention redundant · trägt die Adhärenz (80 % → 45 %)	aus 2.2 heraus, bleibt Adhärenzreferenz in 6.3 (F16 § 12 G5)
Price et al. (2004)	Volltext	Audit ohne Expositionszeit, 1999–2001	1/–/2	Akademie	Anstieg nach Pausen nicht als Rate deutbar	nur 2.2 (Wachstumsbeschwerden), Pausenargument entfällt
Dos'Santos et al. (2018)	Volltext	narratives Review, Biomechanik	2/–/1	Richtungswechsel als Leistungs- und Verletzungssituation (S. 2235)	schon in 2.4, trägt optional einen Satzteil	bleibt in 2.4
McBurnie, Harper, et al. (2022)	Volltext	narratives Review	2/–/1	Abbremsen als Leistungs- und Risikofaktor	schon in 2.4	bleibt in 2.4, keine Präventionsausage
Faude et al. (2017)	Abstract, frei zugänglich	MA 14 RCT, 704 TN, 8 reine Jungenstudien, 71 % Fußball	1/1/1	Leistungseffekte von Präventionsprogrammen, Sprint g = 0,80	Brücke zur Leistung, bei einem Satz nicht nötig	Reserve, nicht verwenden
Emery et al.	Abstract	MA, 25 Studien,	2/2/2	Jugendsport,	redundant	entfällt

(2015)		RCT-MA untere Extremität IRR 0,64		beide Geschlechter		
Thorborg et al. (2017)	Abstract	MA 6 Cluster-RCT, Hauptanalyse RR 0,75 [0,57–0,98]	2/2/2	Amateurfußball, Alter und Geschlecht gemischt	redundant	entfällt
Faude et al. (2013)	Abstract	Review Epidemiologie	1/–/2	Verletzungsmuster im Jugendfußball	Epidemiologiesatz nicht vorgesehen	entfällt
Rössler et al. (2018, 2019)	Abstract, frei zugänglich	Cluster-RCT und Kosteneffektivität, 11+ Kids	2/2/2	Kinderfußball, Ø 10,8 Jahre	redundant, Kostenargument nicht vorgesehen	entfallen
Gebert et al. (2020)	Abstract, frei zugänglich	Querschnitt, Versicherungsdaten	2/–/2	Amateurfußball, überwiegend Erwachsene	Kostenargument nicht vorgesehen	entfällt
Towlson et al. (2021)	Abstract, frei zugänglich	narratives Review Reifung	1/–/1	Belastung um den PHV	gehört nicht zur Präventionsschiene	nur falls Task 10 es für 2.2 braucht
Soligard et al. (2008) · Rössler et al. (2016) · Bull et al. (2020) · Faigenbaum & Myer (2010)	Abstract	RCT Mädchen · Motorik Kinder · WHO-Leitlinie · Positionspapier	≥ 4	fern	nicht gebraucht	entfallen
Quellen der Präsentation zu Screening und Kraftdiagnostik (9)	Abstract	—	≥ 4	kein Bezug zur Fragestellung	—	entfallen (wie Rev. 1)
Pucsok et al. (2021)	Abstract	unkontrolliert, n = 11, Heimtraining im Lockdown, MDPI	1/2/1	einziges bekanntes Heimprogramm im Jugendfußball	Gegenbefundprüfung der Lücke: kein Widerspruch, solange die Lücke „kontrolliert“ heißt	nicht zitieren

Ergebnis: Eine Kernquelle (Olivier 2026). Zwei Quellen bleiben für andere Aufgaben (Hilska 2021 für die Adhärenz, Dos'Santos 2018 in 2.4). Eine Reserve ohne Beschaffung (Faude 2017). Die DOI-Liste von Rev. 1 bleibt im Archiv nachschlagbar, ein Arbeitsauftrag ist sie nicht mehr.

4 Gesamtbild

4.1 Aufbau des Strangs

Leistung bleibt der Zweck nach Antrag. Warum ein Verein des leistungsorientierten Breitensports ein solches Angebot machen sollte, begründen drei Stützen und ein Zusatz. Die Satzkerne sind Inhalt, kein Textvorschlag.

Ebene	Satzkern	Ort	Umfang	Quelle (alle im Ordner)
Zielgrößen	Sprint, Richtungswechsel und Sprung tragen hochintensive Spielaktionen auf jedem Niveau	2.4	besteht (Fassung 6)	wie Fassung 6 · Absatz 1, Satz 5 mit Population „zum leistungsstarken Nachwuchsfußball“ (+1 Wort)
Zielgrößen, optional	Richtungswechsel sind zugleich typische Situationen von Verletzungen der	2.4, Absatz 3	≈ 12 Wörter	Dos'Santos et al. (2018, S. 2235), schon zitiert

	unteren Extremität			
Stütze 1: Machbarkeit	Vereine unterhalb der Akademiebene haben wenig Personal und Zeit für Athletik, ein gerätefreies Videoprogramm ist niederschwellig	Kapitel 1, Zug 1	1 Satz	McBurnie, Parr, et al. (2022) · Nutzenangabe des Ethikantrags
Stütze 2: Zeitfenster	Die Sommerpause ist Zeit ohne Mannschaftstraining, die sich nutzen lässt	Kapitel 1, Zug 1 · 2.3 besteht	½ Satz	Silva et al. (2016), Erwachsene, Meinungsbeitrag
Zusatz: Prävention	Sprungübungen gehören zu mehrteiligen neuromuskulären Programmen, die bei männlichen Jugendlichen Verletzungen senkten · in einer älteren Metaanalyse, überwiegend an Spielerinnen, gingen Programme mit Sprungübungen mit stärkeren Rückgängen einher als Programme ohne (Klick 1)	Kapitel 1, Zug 2	1 bis 2 Sätze, ≈ 50 Wörter	Olivier et al. (2026) · Rössler et al. (2014, S. 1741)
Stütze 3: Lücke	Die Evidenz stammt aus Akademien, kontrollierte Studien zu unbeaufsichtigten Heimprogrammen in der Pause fehlen	Kapitel 1, Zug 4 · 2.3 besteht	1 Satz	Oliver et al. (2024, S. 623, 625)
Kontext: Detraining	Die Richtung bei U15 ist offen, Reifung überlagert den Reizentzug	2.3	besteht, Task 8 kürzt	Silva, Dambel, Asimakidis, Clemente 2022, Liu
Ausblick	Verletzungen als Endpunkt eines solchen Angebots prüfen · ob Spieler mit hoher Umsetzung stärker profitieren, ist eine Hypothese für größere Stichproben	Kapitel 7	2 Satzteile	keine (Bauplan Kapitel 7)

4.2 Präventionsanteil vorher und nachher

Ort	Master heute	nach Empfehlung	Task
2.1 Vorverweis „präventives Potenzial ... in Abschnitt 2.2 dargestellt“	20	0	9
2.2 Satz mit Hilska (2021) und Olivier (2026) samt Kennzahlen	65	0	10
2.4 Satzteil Richtungswechsel (optional)	0	≈ 12	7
Kapitel 1 Präventionssätze mit Sprungbefund (Klick 1)	0	≈ 50	14
Kapitel 7 Satzteil im Ausblick	0	≈ 12	13
Summe	85	≈ 65–75	

4.3 Grenzen für den Präventionssatz

- Quellenart und Population gehören in den Satz: Metaanalyse randomisierter Studien, männliche Jugendliche. Der Befund steht im Präteritum.
- Aussage über die Programmklasse, nicht über das eigene Programm. Kein „präventiv wirksam“ für das Heimprogramm.
- Nicht „im Jugendfußball“: 6 der 18 Studien betrafen andere Sportarten (T4 Olivier2026).
- Keine Zahl in Kapitel 1. Wird doch eine gebraucht, dann die Inzidenz (RR 0,67, $I^2 = 0\%$, hohe Sicherheit), nicht die Verletzungszahl mit $I^2 = 80\%$.
- Keine Aussage, dass Sprungübungen den Schutzeffekt tragen (§ 2).
- **Sprungbefund (Klick 1):** als Zwischen-Studien-Vergleich formulieren („gingen einher mit“, „schnitten besser ab“), nicht als Wirkung der Sprungübungen. Die Population „überwiegend Spielerinnen“ gehört in den Satz. Eine Zahl ist nicht nötig, falls doch: RR 0,45 gegen 0,74, p nur aus dem Ergebnisteil (0,003). Vor-2020-Halbsatz nach F16 § 6.2: Tragfähig ist, dass Olivier (2026) die Übungsarten nicht vergleicht. „Einzigste Metaanalyse mit diesem Vergleich“ nur nach einer Suche. Vor der Formulierung T4 Roessler2014 lesen.

4.4 Was nicht trägt

- Detraining als alleinige Begründung. 2.3 zeigt die offene Richtung bei U15.
- „Breitensport profitiert stärker“. Behm (2017) und de Villarreal (2009) sind uneinheitlich, Rössler (2014) vergleicht die Niveaus a posteriori.
- „Motivierte machen einen Sprung“ aus den eigenen Daten (§ 11.2b). Zulässig nur als Hypothese im Ausblick.
- Prävention als Wirkung des eigenen Programms. Verletzungen wurden nicht erhoben, das Programm war unbeaufsichtigt und dauerte sechs Wochen. Es übt mit 1.040 Bodenkontakten Landen und Abbremsen (P-05 bis P-07), ihm fehlen aber Technikrückmeldung, exzentrisches Training der hinteren Oberschenkelmuskulatur und Gleichgewichtsübungen.
- Gesundheit, Screening, Kraftdiagnostik und Kosten.

5 Korrekturen an Rev. 1

7. $p = 0,002$ für den Sprung-Subgruppenvergleich stammt aus dem Abstract. Der Ergebnisteil nennt $p = 0,003$ (S. 1741).
8. „Die fehlende Brücke existiert in der Literatur“ und „Indikativ gedeckt ... im Jugendfußball“ überbewerten den Befund. Tragfähig ist: Mehrteilige Programme, zu denen Sprungübungen gehören, senkten Verletzungen im Jugendsport. Dass Sprungübungen den Unterschied machen, ist nicht belegt (§ 2).
9. Thorborg et al. (2017) stand mit IRR 0,61 („-39 %“) in der Liste. Das ist die Sekundäranalyse der vier 11+-Studien. Die Hauptanalyse aller sechs Studien ergibt RR 0,75 [0,57–0,98], FIFA 11 allein zeigte keinen Effekt.
10. Die Vorbereitung als Risikophase stützte sich auf Price et al. (2004). Der Anstieg nach den Pausen ist ohne Expositionszeit beschrieben (T4 Price2004), mehr Training lässt sich darin von höherem Risiko nicht trennen. Das Argument entfällt.
11. Kapitel 1 ist Task 14, nicht Task 13. Task 13 ist Kapitel 7 mit Zusammenfassung und Abstract (Plan § 8).
12. Rev. 1 sah Präventionssätze in 2.1 und 6.3 vor. Beides entfällt. 2.1 trägt den Mechanismus ohne Wirksamkeitsaussagen (F16 § 6.4, Rollentrennung), und 6.3 muss eine Aussage, die die Arbeit nicht macht, nicht einschränken. Die Belastungsverträglichkeit um den PHV bleibt Thema von 2.2 und der unerwünschten Ereignisse in 5.1, unabhängig von diesem Strang.

6 Folgen

Nr.	Folge	Ort	Task	Stand
1	Relevanzstützen und Präventionssätze nach § 4.1 und § 4.3, mit Sprungbefund	Kapitel 1	14	offen
2	Ausblick mit zwei Satzteilen	Kapitel 7	13	offen

3	Präventionssatz in 2.2 entfällt, Hilska (2021) wandert in die Adhärenzdiskussion	2.2, 6.3	10, 12	offen
4	Vorverweis in 2.1 entfällt	2.1	9	offen
5	Kein Verletzungsgipfel nach Pausen, Lücke als „kontrolliert“ formulieren	2.3	8	offen
6	2.4 Fassung 7: Satzteil Richtungswechsel und Populationsangabe in Absatz 1	2.4	7	Übergabe 04_Uebergaben\ Uebergabe_2.4_Fas- sung7_2026-09- 28.md liegt vor
7	T1 Roessler2014, T4 vier Einträge Roessler2014	Schreiben\ ev3_daten	—	erledigt 28.09.
8	T1 Price2004: Vormerkung „Pausenanstieg 2.3/6.2“ gegenstandslos	T1	8	mit Task 8
9	H11 geschlossen, G34 neu gefasst	Maßnahmenliste	—	erledigt 28.09.
10	F17: § 6.5 „Rössler et al. (2014) nur für den Sprungbefund, als Zwischen-Studien-Vergleich mit Population“ · § 13 die Entscheidungen der Klicks 1 bis 3	Projektanweisungen	nächste Fassung	offen

Nach dem Neuzuschnitt (§ 8) gehen die Nummern 1 und 3 bis 5 in Task 7 neu (Einleitung) auf. Nummer 6 ist gegenstandslos, die beiden Änderungen sind Kandidaten in der Einleitung.

7 Klickfragen

13. **Quelle des Präventionssatzes.** Empfehlung: Olivier (2026) allein, Rössler (2014) bleibt dokumentiert und wird nicht zitiert. Alternativen: Olivier und Rössler ohne Sprungbefund (Vor-2020-Halbsatz nötig) · zusätzlich der Sprungbefund aus Rössler mit Population im Satz (etwa +20 Wörter).
14. **Ort.** Empfehlung: ein Satz in Kapitel 1 und ein Satzteil in Kapitel 7, der Satz in 2.2 und der Vorverweis in 2.1 entfallen. Alternativen: in 2.2 gekürzt ohne Kennzahlen belassen, nichts in Kapitel 1 · Kapitel 1 und 2.2.
15. **Inhalt des neuen Tasks.** Empfehlung: 2.4 Fassung 7 = Fassung 6 mit dem Satzteil Richtungswechsel und der Populationsangabe (etwa +13 Wörter), der Relevanzstrang kommt in Kapitel 1 (Task 14). Alternativen: 2.4 bleibt Fassung 6, weiter mit Task 8 · 2.4 Fassung 7 mit eigenem Relevanzabsatz (etwa 80 bis 100 Wörter, über der Zielspanne 300 bis 400).

Antworten (Verfasser, 28.09., 14:36): 1. Zusätzlich der Sprungbefund aus Rössler (2014), abweichend von der Empfehlung. Die Folgen stehen in § 4.1 bis § 4.3 und in T1 (Roessler2014, Kapitel 1). 2. Kapitel 1 und Ausblick, wie empfohlen. 3. 2.4 Fassung 7, minimal, wie empfohlen. Übergabe: 04_Uebergaben\
Uebergabe_2.4_Fassung7_2026-09-28.md.

Zweite Runde (Verfasser, 28.09., 14:38 und 14:57): Kapitel 1 und 2 werden unter „Einleitung“ zusammengefasst. Per Klick: alles in die Einleitung, auch Forschungsstand und Hypothesen · höchstens 1.500 Wörter als Antwort auf die Fragen nach Unterabschnitten und Budget (§ 8).

8 Neuzuschnitt: eine Einleitung mit höchstens 1.500 Wörtern

Entscheidung (Verfasser, 28.09., 14:38 und Klick 14:57): Kapitel 1, 2 und 3 werden ein Kapitel „Einleitung“ ohne Unterabschnitte mit höchstens 1.500 Wörtern Absatztext. Die Vorgabe des SMK-Leitfadens, den Forschungsstand in einem eigenen Kapitel zu beschreiben (Abschn. 4.1), gilt damit für die Arbeit nicht mehr.

Folgen für den Relevanzstrang:

- Alle Stützen stehen in der Einleitung: Machbarkeit und Zeitfenster in der Eröffnung, die Präventionssätze bei der Beschreibung des Trainingsmittels (etwa 45 Wörter), die Lücke vor dem Zweck. Der Ausblick trägt weiter einen Satzteil.
- Die Stellen in 2.1 und 2.2, die § 4.2 streicht, entfallen mit dem Neuzuschnitt ohnehin. Prävention umfasst danach rund 45 Wörter in der Einleitung und einen Satzteil im Ausblick, gut 3 % der Einleitung.
- Die zwei für 2.4 Fassung 7 vorgesehenen Änderungen (Populationsangabe bei Oliver 2024, Richtungswechsel als typische Verletzungssituation) sind Kandidaten für den Zielgrößenteil der Einleitung.

Folgen für die Arbeit: Gesamt 6.350 statt 9.000 Wörter, Seitenprognose rund 21 statt 30 · Gliederung 1 Einleitung · 2 Methodik · 3 Ergebnisse · 4 Diskussion · 5 Fazit und Ausblick, bis Task 18 mit den Arbeitsnummern 4 bis 7 · die Tasks 7 bis 10 und der Einleitungsteil von Task 14 werden ein Task.

Übergabe: 04_Uebergaben\Uebergabe_Einleitung_2026-09-28.md mit Bauplan (acht Züge, etwa 1.390 Wörter), Pflichtinhalten, Verbleibsliste und Startsatz.